

## TEMA 5.15 • OFTALMOLOGÍA

## síndrome de ojo seco

PERFIL EUNACOM 6.02.5.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

## Manejo del Cuerpo Extraño Ocular

El manejo y retiro clínico eficiente de un cuerpo extraño varían drásticamente dependiendo directamente de la ubicación anatómica de su impacto e incrustación (superficial vs penetrado profundo).

## 1. Cuerpo Extraño en Conjuntiva Tarsal / Párpados

Son la ocurrencia general básica de urgencias periféricas oculares donde el paciente percibe roce intermitente fuerte en cara interna tras parpadear continuo. - **Táctica de remoción general superior (Tarsal)**: Requiere visualización directa usando la ineludible técnica en resorte de **Eversión del Párpado Superior**. - **Táctica de remoción general inferior (Fórnix)**: Basta bajar gentilmente el reborde ciliar. Y siempre solicitando al paciente la mirada pasiva cruzada opositora al hallazgo. - **Tratamiento extra**: Tras removerlos con un torundero limpio, siempre debe descartarse **erosiones corneales** concomitantes friccionadas provocadas pos contacto con tinción minuciosa obligatoria con uso de solución en **Fluoresceína**. Dejado posteriormente cobertura base antibiótica en ungüento para úlceras si existieran.

## 2. Cuerpo Extraño Impactado en Córnea

Partículas enclavadas directamente en el estroma epitelial de la córnea producto de un impacto mayor. - **Intentos Primarios Válidos para Nivel General**: 1. Irrigación franca copiosa y vigorosa repetitiva de base usando **Suero o Agua a Chorro** directo por jeringa lavando mecánicamente toda la adherencia. 2. Fallando eso, uso cuidadoso perimétrico de instrumento tipo **hisopo/cotonito** humedecido; bajo una leve premedicación oftálmica con una prudente gota basal de un anestésico superficial transitorio (ej: Proparacaína). - **Contraindicaciones de nivel generalista Médico**: - Todo remanente incrustado profundizado testarudo requiriendo escarbado anatómico incipiente de punción delicada extractiva frontal aguda y abrasiva a través de aguja bisturí milimétrico resulta técnica prohibida general de riesgo en el facultativo inexperto primaria por alto riesgo perforante de desastre global del segmento ocular estromal. **Se deriva al oftalmólogo experto de guardia**.

## 3. Cuerpo Extraño Penetrante / Intraocular

Restos y proyectiles traspasando esclerótica o la propia cámara profunda masacrando córnea y flotante tras estallido directo traumático fuerte.

## EUNACOM CRITERIOS

**Prohibición Absoluta Quirúrgica Básica** Al constatarse o existir un margen profundo ocular de invasión intraocular del perno o esquiria transfixiante: se manejan y gobiernan generalizados y universales estrictamente de manera equivalente al severo y desastroso protocolo del **Trauma Ocular Abierto o Penetrante**. **Jamás tocar o forzar manualmente el objeto incrustado ocular**, ni jalarlo perimetralmente fuera del pabellón por riesgo enorme natural expuesto catastrófico del sangrado profundo general masivo en arrastre con tejido eviscerante y la necrosis o pérdida intraescleral anatómica. Derivación urgente a la Unidad de urgencia Trauma especializada centralizada en bloque.

## Resumen: Técnica de Eversión Anatómica Clásica del Párpado Superior

Procedimiento Semi-Invasivo universal semiológico base clínico rutinario de inspección: 1. Traccionar gentil y delicadamente pestañas frontales, controlando no estirar o dañar permanentemente la inserción frágil propia. 2. Instruir en base general obligatoria: **Paciente Fija la mirada siempre hacia abajo de manera constante**. 3. Ejercer contrapresión a eje nivel basal transversal a través del uso de de palo estéril romo (hisopo cotonito, puntero engomado o similar) doblándose el párpado mismo volcado para exteriorizar rojo vivo. 4. Finalizado los chequeos médicos el simple repliegue instintivo natural y automático para normalizar, simplemente ocurre indicando oralmente que el sujeto retome voluntariamente su vista directamente en giro ocular de rebote normal simple elevante dirigido en **"Mirar hacia Arriba"**.

## CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

## ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Una mujer de cuarenta y cinco años consulta por ojo rojo bilateral crónico, sensación de arenilla y paradójicamente lagrimeo ocasional. Refiere además boca seca desde hace un año. Al examen con fluoresceína se observan múltiples puntitos que captan el colorante en la córnea inferior bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

## EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para síndrome de ojo seco. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

## PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El síndrome de ojo seco produce sensación de arenilla, ojo rojo y puede complicarse con queratitis puntata y úlceras corneales.
- La epífora paradójica en el ojo seco se produce como reacción refleja a la irritación ocular, aunque parece contradictorio.
- La causa más importante es el síndrome de Sjögren: afecta glándulas exocrinas produciendo ojo seco más boca seca xerostomía.
- Otras causas de ojo seco son: parálisis facial, neuropatías con reducción del parpadeo, orbitopatía distiroidea y causas idiopáticas.
- El diagnóstico se confirma con el test de Schirmer: papel filtro en el fondo de saco conjuntival que mide cuántos milímetros se humedece en cinco minutos.
- El tratamiento son las lágrimas artificiales de uso frecuente más el manejo de la causa subyacente.

## EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME DE OJO SECO)

## PREGUNTA 1

Una mujer de cuarenta y cinco años consulta por ojo rojo bilateral crónico, sensación de arenilla y paradójicamente lagrimeo ocasional. Refiere además boca seca desde hace un año. Al examen con fluoresceína se observan múltiples puntitos que captan el colorante en la córnea inferior bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Conjuntivitis alérgica bilateral
- B) Síndrome de ojo seco por síndrome de Sjögren
- C) Queratitis herpética bilateral
- D) Queratitis actínica por exposición a ultravioleta
- E) Glaucoma crónico bilateral

## PREGUNTA 2

Un médico general va a realizar el test de Schirmer para confirmar el diagnóstico de ojo seco. ¿Cuál es la descripción correcta de cómo se realiza este test?

- A) Se instilan gotas de colorante en el ojo y se mide el tiempo en desaparecer
- B) Se coloca una tira de papel filtro en el fondo de saco conjuntival inferior y se mide cuántos milímetros se humedece en cinco minutos
- C) Se evalúa con lámpara de hendidura la capa de lágrima en la córnea
- D) Se mide la presión intraocular con tonometría de aplanamiento
- E) Se realiza cultivo de la secreción lagrimal para identificar el agente etiológico

## PREGUNTA 3

Un paciente con parálisis facial periférica izquierda de tres meses de evolución desarrolla ojo rojo izquierdo con sensación de arenilla y úlcera corneal inferior. ¿Cuál es el mecanismo que explica el ojo seco en este paciente?

- A) La parálisis facial reduce la producción de lágrima por deservación de la glándula lagrimal
- B) La parálisis del músculo orbicular impide el cierre ocular, exponiendo la córnea al ambiente y provocando ojo seco por exposición
- C) La parálisis facial bloquea el reflejo de parpadeo produciendo exposición corneal
- D) La parálisis facial produce inflamación de la glándula lagrimal reduciendo la producción de lágrima
- E) El nervio facial inerva directamente la córnea y su parálisis produce anestesia corneal con ojo seco neurotrófico

## RESUMEN: SÍNDROME DE OJO SECO

El síndrome de ojo seco es una patología muy frecuente en la práctica clínica, caracterizada por una producción insuficiente de lágrima o por lágrima de mala calidad. La clínica es inespecífica: sensación de arenilla, ojo rojo, molestias oculares y en ocasiones epífora paradójica, es decir, lagrimeo excesivo que puede parecer contradictorio pero que se produce como reacción refleja a la irritación. Las complicaciones más importantes son la queratitis sica o puntata, que son erosiones múltiples puntiformes del epitelio corneal visibles con fluoresceína, y en casos avanzados, úlceras corneales. La causa más importante que hay que conocer es el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune del tejido conectivo que afecta las glándulas exocrinas. Produce ojo seco por afectación de las glándulas lagrimales y boca seca o xerostomía por afectación de las glándulas salivales. Otras causas son la parálisis facial que impide el parpadeo, neuropatías que reducen el reflejo de parpadeo, y la orbitopatía distiroidea que produce proptosis y exposición corneal. El diagnóstico se hace con el test de Schirmer, que mide la cantidad de lágrima producida colocando una tira de papel filtro en el fondo de saco conjuntival inferior y midiendo cuántos milímetros se humedece en cinco minutos. El tratamiento principal son las lágrimas artificiales de uso frecuente. Se puede añadir lubricante ocular en gel que dura más tiempo. El manejo de la causa subyacente es fundamental.